



SENA, BITTAR E SIMÕES

CONSULTORIA E ASSESSORIA MÉDICA EMPRESARIAL

## Plano de mentoria

Documento de trabalho dos sócios · versão 2, 06/out/2026

### 1. De onde este plano sai

Os quatro pilares, as frases e os indicadores vêm do vídeo de apresentação que vocês já fecharam ( [Video Sena e Bittar.mp4](#) ). Nada aqui foi inventado:

| PILAR            | A TESE, COMO ESTÁ NO VÍDEO                          | O QUE O SISTEMA MEDE                             |
|------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 01 Gestão        | "A base. O resto se apoia nela."                    | Sobra do mês, depois de imposto e retirada       |
| 02 Marketing     | "O paciente certo precisa te encontrar."            | Pacientes novos, e quantos vieram por indicação  |
| 03 Vendas        | "Consulta marcada ainda não é paciente tratado."    | Tratamentos fechados, sobre os orçamentos do mês |
| 04 Lucratividade | "Faturar mais e lucrar mais são contas diferentes." | Margem líquida do mês                            |

E o aviso que amarra tudo, também do vídeo: "A agenda lota. O caixa não acompanha. Marketing e vendas em cima de uma base fraca só fazem você trabalhar mais pra sobrar o mesmo."

O método por baixo é o dos **5 G's da Gestão Empreendedora**, livro do Gilberto. A ficha de anamnese de 25 perguntas que já existe ( [saidas/ficha-anamnese-mentoria-5gs-2026-08-23/](#) ) é a base do diagnóstico, adaptada ao consultório na seção 4.

### 2. Para quem é, e para quem não é

**Quatro públicos**, todos donos da própria estrutura. O vídeo já abre o leque: "Vale pra toda a área da saúde."

| PÚBLICO     | ESTRUTURA TÍPICA                                         |
|-------------|----------------------------------------------------------|
| Médico      | consultório próprio ou sociedade em clínica              |
| Dentista    | consultório odontológico, sozinho ou com equipe          |
| Biomédico   | laboratório de análises clínicas, ou atuação em estética |
| Esteticista | clínica de estética, com ou sem formação na saúde        |

Os quatro pilares são os mesmos para todos. O que muda de verdade entre eles é a **conta tributária**, e a diferença é grande. Ver a seção 8: médico, dentista e biomédico têm situação confirmada; estética é zona cinzenta. Isso muda o discurso de venda e muda o trabalho.

O vocabulário do consultório também muda: procedimento, sessão, protocolo, pacote. Vale ajustar a conversa, não o método.

**Não é para:** profissional exclusivamente CLT ou plantonista sem estrutura própria. Sem negócio não existem os quatro pilares, e o programa vira coaching financeiro pessoal, que é outro produto.

**A dor que eles trazem, em geral:** trabalha mais do que nunca, a agenda está cheia, e não sobra. A promessa do programa é devolver a resposta de *onde o dinheiro está se perdendo* e fechar esse buraco em 90 dias.

Na estética a dor tem um acréscimo: além de não sobrar, o profissional quase sempre não sabe em que alíquota vai cair depois da reforma. Essa insegurança é, hoje, o melhor argumento de entrada desse público.

**O que não prometer:** faturamento garantido, número de pacientes novos, percentual de crescimento. Os números do vídeo estão marcados "EXEMPLO" de propósito. Manter essa disciplina na venda e na mentoria.

### 3. O formato

**90 dias.** É o ciclo que o Gilberto já usa e o que cabe num trimestre fiscal, o que facilita medir.

|                                |                                                       |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Encontro de abertura           | 2h, presencial ou vídeo, os três sócios presentes     |
| Encontros quinzenais           | 1h30, 6 encontros ao longo dos 90 dias                |
| Acompanhamento entre encontros | canal direto, resposta em até 1 dia útil              |
| Fechamento                     | 2h, leitura dos indicadores e decisão sobre continuar |

#### 3.1 Quem é dono de quê

Cada sócio conduz o pilar que é território dele. Mais que dividir agenda, isso divide autoridade: quem fala de cada assunto é quem vive aquele assunto.

| SÓCIO         | ESPECIALIDADE                                        | PILAR QUE CONDUZ         |
|---------------|------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Sena</b>   | Gestão de negócios · Contábil · Tributária · Pessoal | 01 Gestão                |
| <b>Bittar</b> | Médico estrategista · Marketing e Vendas             | 02 Marketing e 03 Vendas |
| <b>Simões</b> | Finanças · explicar Smart Money                      | 04 Lucratividade         |

**Por que essa divisão funciona na frente do cliente.** O médico sentado ali sabe diferenciar quem fala de dentro de quem fala de fora. Bittar é médico, e isso resolve a resistência que todo consultório tem a ouvir gestão de quem nunca atendeu. Sena traz a conta e a estrutura, que é onde mora o imposto e a folha. Simões entra depois que sobra dinheiro, que é quando a conversa deixa de ser sobrevivência e vira patrimônio.

**Os três juntos** na abertura e no fechamento. No meio, cada um conduz o seu, mas todos leem o que os outros decidiram antes do encontro seguinte. Mentoria em que um sócio desconhece a decisão do outro vira três consultorias soltas dentro do mesmo contrato.

## 3.2 Cronograma dos 90 dias

| DIAS    | ENCONTRO               | PILAR            | CONDUZ         | O QUE SAI DE LÁ                                                                                                        |
|---------|------------------------|------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 a 15  | Abertura e diagnóstico | Todos            | <b>Os três</b> | Linha de base dos indicadores, mapa de classificação dos serviços e as três decisões do trimestre                      |
| 16 a 30 | 1                      | 01 Gestão        | <b>Sena</b>    | Contas separadas, pró-labore definido, rotina de fechamento com dono e data                                            |
| 31 a 45 | 2                      | 01 Gestão        | <b>Sena</b>    | Regime tributário decidido, reserva de caixa com meta, folha organizada                                                |
| 46 a 60 | 3                      | 04 Lucratividade | <b>Simões</b>  | Margem por procedimento, tabela de preço revista, decisão sobre mix e convênios, e o critério do Smart Money explicado |
| 61 a 70 | 4                      | 02 Marketing     | <b>Bittar</b>  | Posicionamento por procedimento, origem de paciente rastreada, presença mínima viável                                  |
| 71 a 80 | 5                      | 03 Vendas        | <b>Bittar</b>  | Caminho da primeira mensagem à consulta, conversa de orçamento, recall e indicação                                     |
| 81 a 90 | 6                      | Amarração        | <b>Os três</b> | Indicadores contra a linha de base, agenda do dono revista, desenho do próximo ciclo                                   |

**Por que Lucratividade vem antes de Marketing.** É o aviso do próprio vídeo: *marketing e vendas em cima de uma base fraca só fazem você trabalhar mais pra sobrar o mesmo*. Preço corrige margem já no mês seguinte; marketing leva um trimestre pra aparecer. Encher a agenda antes de arrumar o preço é comprar trabalho.

**Depois dos 90 dias.** O critério do Smart Money só vira decisão real quando a empresa já tem ponto de equilíbrio coberto e reserva formada. Antes disso, falar de investimento é conversa bonita em cima de caixa frágil. O médico sai dos 90 dias sabendo **o que perguntar e como decidir**; onde ele vai pôr o dinheiro é escolha dele, com quem for habilitado. Esse é o gancho natural do segundo ciclo.

## 4. Fase 1: diagnóstico (dias 1 a 15)

É o "Diagnóstico do seu consultório" que o vídeo promete. Sai um documento, não uma conversa.

### 4.1 A anamnese do consultório

A ficha dos 5 G's já existe e serve. O que muda para médico é o vocabulário e cinco perguntas que só fazem sentido aqui. Estas entram:

#### Sobre a base (Gestão)

1. A conta da clínica e a sua conta pessoal são a mesma conta? Com que frequência uma paga a despesa da outra?
2. Você sabe dizer, sem abrir nada agora, quanto sobrou no mês passado depois de imposto e da sua retirada?
3. Qual é o seu regime tributário hoje, e quem decidiu por ele?
4. Você tem pró-labore definido, ou tira conforme o caixa permite?
5. Quanto do seu faturamento vem de convênio e quanto vem de particular?

#### Sobre o paciente (Marketing)

6. Quando alguém te indica, a pessoa diz o quê sobre você? Por qual procedimento você é lembrado?
7. De onde veio cada paciente novo do mês passado? Você sabe ou chuta?
8. Quem responde a primeira mensagem do paciente, e em quanto tempo?

### Sobre a conversão (Vendas)

9. De cada dez orçamentos que você apresenta, quantos viram tratamento?
10. O que acontece com o paciente que ouviu o orçamento e não voltou?
11. Quanto do seu faturamento vem de paciente que já era seu?

### Sobre a margem (Lucratividade)

12. Qual dos seus procedimentos dá mais margem? E qual você mais faz?
13. Há quanto tempo você não reajusta preço?
14. Se a sua agenda dobrasse amanhã, o que quebraria primeiro?

### Para quem faz estética (pergunta obrigatória)

15. Dos seus procedimentos, quais têm finalidade terapêutica e quais são de embelezamento? Como eles aparecem hoje na nota fiscal?

A pergunta 14 costuma ser a que abre a conversa de verdade. A 15 é a que vale mais dinheiro, pelo motivo da seção 8.

## 4.2 Levantamento de números

Pedir antes do encontro de abertura, para não queimar a reunião coletando dado:

- Extrato bancário da clínica dos últimos 6 meses
- Faturamento mês a mês dos últimos 12 meses, separado convênio x particular
- Guias de imposto dos últimos 6 meses
- Folha, se houver equipe
- Lista de procedimentos com preço praticado
- Agenda dos últimos 3 meses, com número de atendimentos
- Amostra de notas fiscais emitidas, para ver como o serviço está descrito hoje. É dali que sai o mapa de classificação

## 4.3 O que é entregue no fim da fase 1

Um documento com:

1. **A linha de base dos quatro indicadores.** Sobra do mês, pacientes novos, conversão de orçamento, margem líquida. Com o método de cálculo escrito, para que o médico saiba de onde saiu cada número.
2. **Onde o dinheiro está se perdendo.** O ranking dos vazamentos, do maior para o menor, em reais por mês.
3. **A conta do regime tributário.** Comparativo do regime atual contra as alternativas, com a conta feita. Ver a seção 8 sobre a reforma.
4. **O mapa de classificação dos serviços.** Cada procedimento da tabela ligado à sua classificação, separando o que é saúde do que é embelezamento. Para médico, dentista e biomédico isso confirma o enquadramento. Para quem faz estética, isso é o trabalho principal, e é onde está o risco e o ganho.
5. **As três decisões do trimestre.** Não dez. Três.

---

## 5. Fase 2: plano de ação nos quatro pilares (dias 16 a 80)

---

Seis encontros quinzenais, com o calendário e o condutor de cada um na seção 3.2. A ordem abaixo inverte a numeração do vídeo, de propósito.

### Por que a ordem muda

O vídeo numera Gestão, Marketing, Vendas, Lucratividade, que é a ordem da jornada do paciente. Para **executar**, a ordem é outra, e quem diz isso é o próprio vídeo: *marketing e vendas em cima de uma base fraca só fazem você trabalhar mais pra sobrar o mesmo*.

Então: primeiro a base, depois o preço, só então o volume.

Se vocês preferirem manter a numeração do vídeo também na execução, é decisão de vocês. Mas o médico que entra em marketing antes de arrumar preço costuma voltar em seis meses mais cansado e com a mesma sobra.

## Encontros 1 e 2: Gestão, a base

**Conduz: Sena** · gestão de negócios, contábil, tributária e pessoal

O que sai arrumado:

- Conta pessoa física separada da conta da clínica, de verdade, com data
- Pró-labore definido em valor, não em sobra
- Regime tributário decidido e, se for o caso, com o pedido de mudança protocolado ou agendado para a janela certa
- Rotina mensal de fechamento: quem fecha o mês, até que dia, em que planilha ou sistema
- Reserva de caixa, com meta em meses de custo fixo

Ancora no **2G, Gestão Financeira** do livro: governança, orçamento, fluxo de caixa, investimentos, endividamento, nessa ordem de pirâmide.

## Encontro 3: Lucratividade, o preço

**Conduz: Simões** · finanças, e explicar o Smart Money

- Margem apurada por procedimento, não no agregado
- Custo real da hora do médico, incluindo a hora que ele não atende
- Tabela de preço revista, com data de reajuste definida
- Decisão sobre o mix: qual procedimento ganha agenda e qual perde
- A conta do convênio: qual convênio paga a conta e qual é prejuízo disfarçado de movimento

Esta é a sessão que costuma mudar o resultado mais rápido, porque preço corrige margem no mês seguinte, enquanto marketing leva um trimestre.

**A camada do Simões: explicar o Smart Money.** Arrumada a margem, começa a aparecer sobra, e aí a pergunta deixa de ser quanto entra e passa a ser o que fazer com o que sobrou.

O papel dele aqui é **explicar a lógica**, para o médico passar a enxergar dinheiro parado como decisão e não como conforto. O que é dinheiro inteligente, por que sobra parada em conta perde valor, qual a diferença entre reserva, capital de giro e capital que pode trabalhar, e que perguntas fazer a quem for cuidar do investimento dele.

**O que não acontece nesta sessão:** indicação de produto, de corretora ou de aplicação específica, e nenhuma promessa de retorno. Quem decide onde põe o dinheiro é o médico, com quem for habilitado para isso. A mentoria entrega o critério, não a aplicação.

Essa delimitação é o que mantém o pilar vendável sem criar exposição. O OCEO chegou na mesma conclusão e registrou ([Projetos Gsena Tec/oceo/pilar-5-educacao-pre-investimento.md](#)).

## Encontro 4: Marketing, o paciente certo

**Conduz: Bittar** · médico estrategista, marketing e vendas

- Posicionamento: por qual procedimento este médico quer ser lembrado
- Presença mínima viável, sem virar produtora de conteúdo
- Origem de paciente rastreada: de onde veio cada um, registrado na recepção
- Reputação: avaliação de paciente, indicação ativa, relacionamento com colegas que encaminham

**Trava obrigatória:** tudo dentro das regras do conselho. Ver a seção 8.

## Encontro 5: Vendas, o paciente tratado

**Conduz: Bittar**

- O caminho da primeira mensagem até a consulta, cronometrado
- Quem responde, em quanto tempo, com que script
- A conversa de orçamento: como é apresentada hoje, o que muda
- O retorno do paciente que não fechou: existe ou o orçamento morre sozinho
- Recall e indicação: o paciente que volta e o paciente que traz outro

Ancora no **5G, Gestão de Clientes**: conhecimento, compra, retenção, defesa, recompra.

## Encontro 6: amarração

### Conduzem: os três

- Revisão dos quatro indicadores contra a linha de base
- O que ficou pela metade e por quê
- Gestão de si: a agenda do médico, o que ele parou de fazer para isso caber (**1G**, matriz de urgente x importante)
- Desenho dos próximos 90 dias

## 6. Fase 3: acompanhamento de perto (dias 76 a 90 e adiante)

O vídeo promete "acompanhamento de perto". Em operação:

- **Painel mensal.** Os quatro indicadores numa tela só, como o vídeo mostra. Quanto entrou e quanto sobrou, de onde vem cada paciente, o que ajustar neste mês.
- **Uma pergunta por mês.** Qual é o ajuste deste mês. Um, não cinco.
- **Revisão trimestral.** Replica o diagnóstico e compara com a linha de base.

O painel é o produto que segura o cliente depois dos 90 dias. Vale discutir se ele entra junto da mentoria ou é a camada de recorrência que vem depois.

## 7. O que é medido, e como

Os quatro indicadores precisam de fórmula escrita, senão cada mês é medido de um jeito e a comparação não vale.

Os nomes abaixo são os do painel que aparece no vídeo, letra por letra.

| PILAR     | INDICADOR                                                | COMO CALCULAR                                                                                                                                                                          |
|-----------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gestão    | <b>Sobra do mês</b> , depois de imposto e retirada       | Receita recebida no mês, menos custo fixo, menos custo variável, menos imposto pago, menos pró-labore. É caixa, não competência.                                                       |
| Marketing | <b>Pacientes novos</b> , e quantos por indicação         | Primeira consulta no período, por origem registrada na recepção. Paciente que volta depois de anos conta como retorno. A fatia que veio por indicação é o número que mostra reputação. |
| Vendas    | <b>Tratamentos fechados</b> , sobre os orçamentos do mês | Orçamentos que viraram tratamento iniciado, dividido pelos orçamentos apresentados no mesmo período.                                                                                   |
| Lucro     | <b>Margem líquida</b> , contra a meta do trimestre       | Sobra do mês dividida pela receita do mês. É o número que mostra se faturar mais virou lucrar mais.                                                                                    |

O painel do vídeo ainda traz faturamento e lucro dos últimos 12 meses lado a lado, que é o gráfico que o médico entende sem explicação.

Medir a linha de base no diagnóstico e repetir todo mês, com a mesma conta.

## 8. Duas coisas que precisam ser fechadas antes de vender

### 8.1 A conta da reforma tributária, público por público

Isto está fichado e confere. **Os quatro públicos não estão na mesma situação**, e essa diferença é o coração do argumento de venda.

| PÚBLICO   | SITUAÇÃO NA REFORMA                                                                                                                                             | FICAMENTO                                |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Médico    | <b>60% de redução confirmada</b> , por prestar serviço de saúde (arts. 128-134 da LC 214/2025). O CFM articulou isso no Congresso.                              | reforma-tributaria-medicos.md            |
| Dentista  | <b>60% confirmada</b> , mesma lógica. O CFO articulou. Ganho extra: a não-cumulatividade deixa a clínica creditar imposto pago em despesa e custo da atividade. | reforma-tributaria-odontologia.md        |
| Biomédico | <b>Incluído</b> entre os cerca de 30 serviços de saúde do Anexo VIII, laboratório de análises clínicas citado de forma explícita.                               | reforma-tributaria-biomedicina.md        |
| Estética  | <b>Não tem inclusão confirmada</b> . É zona cinzenta, com risco real de disputa jurídica.                                                                       | reforma-tributaria-clinicas-esteticas.md |

**A regra que vale para os três primeiros:** a redução de 60% de saúde e a de 30% de profissão regulamentada **não somam**. Quando o serviço é saúde, aplica-se a de 60%, que é a maior. A de 30% é alternativa, não acréscimo.

**Por que estética é diferente, e por que isso é oportunidade:**

O que decide não é quem faz, é **como o serviço é classificado** na NBS:

- Procedimento com finalidade **terapêutica** (reconstrução, tratamento de patologia), feito por médico: tende a entrar como saúde, 60%.
- O **mesmo** profissional fazendo procedimento puramente de embelezamento, sem finalidade terapêutica: pode não entrar como saúde. Cairia nos 30% de profissão regulamentada, se ainda contar como atividade ligada à qualificação, ou na alíquota cheia se nem isso.
- **Esteticista sem formação na saúde:** risco real de não se enquadrar em nenhuma redução.

Ou seja: a clínica que mistura procedimento terapêutico com procedimento estético precisa saber separar as duas coisas na classificação. Esse é um trabalho de consultoria real, com valor em reais, e é exatamente o que ninguém está fazendo por esse público hoje.

**O que não afirmar, em venda nem em mentoria:**

- Que estética paga sempre alíquota cheia. Depende do procedimento.
- Que estética tem direito aos 60%. A própria fonte diz que é controverso.
- Que todo procedimento médico ou odontológico entra automaticamente nos 60% sem checar a classificação.
- Número fechado de alíquota. O padrão (26,5% a 28%) ainda não está definido. A estimativa publicada para odontologia, cerca de 11,2% num padrão de 28%, é projeção e deve ser dita como projeção.

### 8.2 As regras dos conselhos sobre publicidade: não tenho

O pilar de Marketing promete "tudo dentro das regras do conselho", e agora são conselhos no plural: CFM para médico, CFO para dentista, CFBM para biomédico. Para o esteticista sem formação na saúde não há conselho equivalente, o que muda a régua de publicidade e precisa ser verificado.

**Não existe nada fichado aqui sobre publicidade** em nenhum dos quatro casos, e eu não vou citar número de resolução de cabeça. Até isso ser levantado, o pilar de Marketing não deveria ser vendido com promessa de conformidade.

Dá para resolver rápido com uma pesquisa dedicada. É o item 1 da lista abaixo.

## 9. O que falta decidir

1. **Levantar as regras de publicidade dos conselhos** (CFM, CFO, CFBM e o que vale para esteticista sem conselho) e fichar, antes de vender o pilar de Marketing. Bloqueia a venda do pilar.
2. ~~Preço do programa:~~ **Decidido em 06/out/2026.** Ver seção 11.
3. **Divisão de receita entre os três sócios.** A divisão de *trabalho* está na seção 3.1; a de dinheiro, não.
4. **O painel é parte da mentoria ou é a recorrência depois dela?**
5. ~~A marca fala "para médicos":~~ **Resolvido em 06/out/2026:** a linha passou a ser "consultoria e assessoria médica empresarial".
6. ~~Delimitar o Smart Money:~~ **Decidido em 06/out/2026:** o papel do Simões é **explicar** o Smart Money, não aplicar nem indicar. Está escrito no encontro 3.

Duas coisas ainda pendentes, e as duas são do Simões:

- **A definição, nas palavras dele.** Smart money no mercado costuma significar capital que vem com experiência e rede junto, não só dinheiro. Escrevi o pilar no sentido de dinheiro que trabalha com critério. Se o sentido dele for outro, o texto do encontro 3 muda.
- **Pôr a delimitação no contrato.** Explicar é posição muito mais segura que indicar, mas conversa ao vivo escorrega: o médico vai perguntar "e onde eu ponho?", e a resposta precisa estar combinada antes. Uma cláusula dizendo que a mentoria é educacional e não constitui recomendação de investimento resolve, e protege os três.
- 7. **Nome completo do sócio Simões,** para a folha de rosto dos dois documentos deixar de falar em "sócios" e passar a nomear os três.
- 8. **Contrato de prestação de serviço** da mentoria, com sigilo, e o acordo entre os três sócios sobre entrada e divisão de receita. Existe modelo em `juridico/` para adaptar.

## 10. Próximas peças que saem deste documento

- ~~A ficha de diagnóstico do consultório, em PDF:~~ **Pronta em 06/out/2026,** em `ficha-diagnostico/`. São 6 páginas, 21 perguntas divididas pelos quatro pilares, mais a folha de fecho com a linha de partida. A pergunta 21 só vale para quem faz estética.
- O modelo do documento de diagnóstico que fecha a fase 1
- A peça comercial de uma página para o médico
- O roteiro do diagnóstico gratuito, que é o que o QR code do vídeo promete

## 11. Preço

Decidido pelo Gilberto em 06/out/2026.

| FORMA                  | VALOR                                              |
|------------------------|----------------------------------------------------|
| À vista, pix ou cartão | <b>R\$ 50.000,00</b>                               |
| Parcelado              | <b>12x de R\$ 5.000,00, total de R\$ 60.000,00</b> |

**A conta embutida.** A diferença entre as duas formas é de R\$ 10.000 em doze meses, o que dá **2,92% ao mês**, ou 41,3% ao ano.

Isso é defensável sem esforço. Cobre o custo de adquirente do cartão, cobre o risco de doze meses de inadimplência, e fica na faixa que o empresário vê todo dia em parcelamento. Se o médico fizer a conta de cabeça, o número não constrange ninguém.

Para registro: na versão anterior deste documento o valor à vista era R\$ 45.000, e aí a taxa embutida subia para 4,73% ao mês, perto de 74% ao ano. Era alto o bastante para virar pergunta na reunião. Subir o à vista para R\$ 50.000 resolveu isso sem mexer na parcela, que é o número que o médico olha primeiro.

Se um dia quiser apertar mais, 12x de R\$ 4.600 (R\$ 55.200) derruba a taxa para 1,56% ao mês. Mas no patamar de hoje não há o que corrigir.

